

MONITORAMENTO NEUROCOGNITIVO DE IDOSOS NA CIDADE MADURA

24 de Agosto – 01 de Outubro

Tiago Souto Rocha

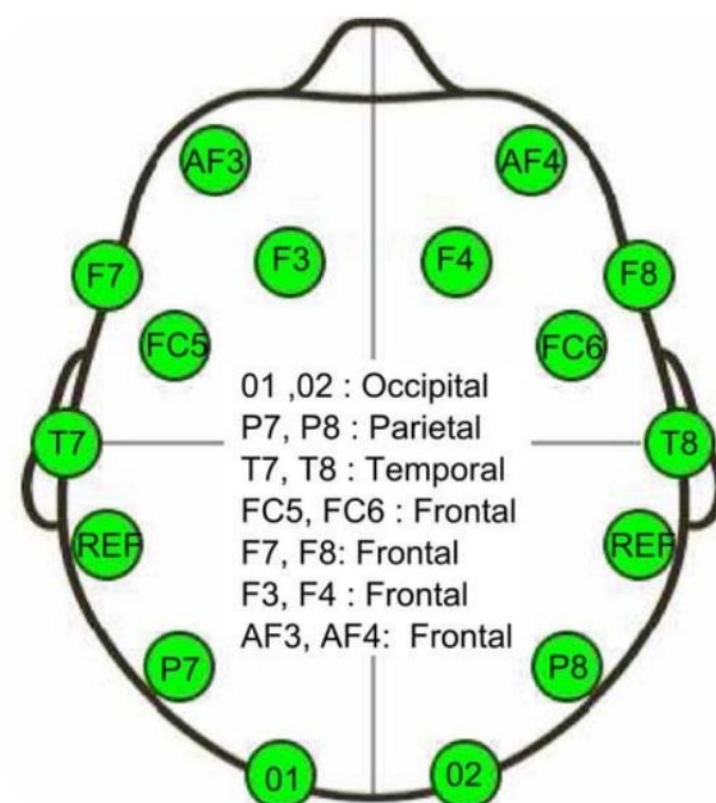
SUMÁRIO

- 1.A CHEGADA DO EEG
- 2.MANUAL DE APLICAÇÃO DO MOCA
- 3.ADIÇÃO DA ANAMNESE ALÉM DO SOCIODEMOGRÁFICO
- 4.PRIMEIRA COLETA EM UMA PESSOA IDOSA
- 5.TEMPLATE E PRIMEIRO RELATÓRIO
- 6.PRIMEIRAS COLETAS NA CIDADE MADURA
- 7.RESULTADOS PRELIMINARES

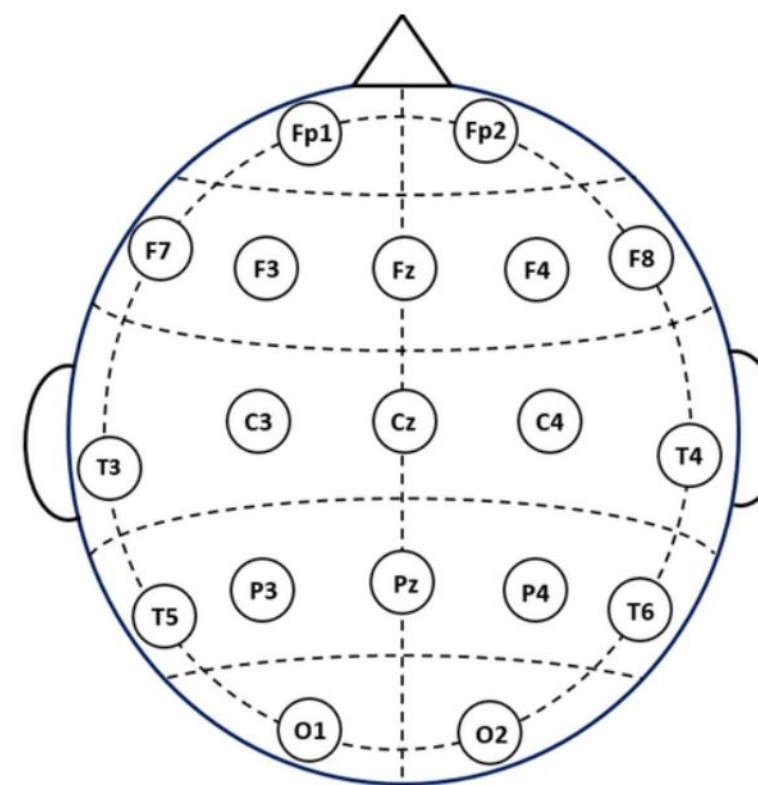
1. A CHEGADA DO EEG



14 CANAIS



19 CANAIS



2.MANUAL DE APLICAÇÃO DO MoCA



PROTOCOLO DE APLICAÇÃO DO TESTE DE RASTREIO COGNITIVO MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MoCA)

Tiago Souto Rocha (<http://lattes.cnpq.br/2236371058575114>)

Alanny Nunes de Santana (<http://lattes.cnpq.br/0810849700298282>)

Emily Souza Gaião e Albuquerque (<http://lattes.cnpq.br/5228087458616792>)

1. Diretrizes Gerais de Aplicação do Teste MoCA em Idosos

1.1. Postura e Comunicação do Avaliador: O avaliador deve manter sempre uma boa dicção. É imperativo falar de maneira pausada e articulando bem a boca em todas as etapas, assegurando que o idoso compreenda corretamente as instruções e os estímulos sonoros.

1.2. Cronometragem

1.2.1. Tempo Total: O tempo de resposta do idoso deve ser cronometrado até a conclusão do teste. Este tempo total deve incluir os momentos de explicação das questões. O valor final deve ser anotado no término da folha de avaliação.

[Link do Manual](#)

Dement Neuropsychol 2022 Setembro;16(3 Supl. 1):1-17

Consenso

<https://doi.org/10.1590/1980-5764-DN-2022-S101PT>

Declínio cognitivo subjetivo, comprometimento cognitivo leve e demência - diagnóstico sindrômico: recomendações do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia

Jerusa Smid¹, Adalberto Studart-Neto¹, Karolina Gouveia César-Freitas¹,
Marcia Cristina Nascimento Dourado², Renata Kochhann³, Breno José Alencar Pires Barbosa^{1,4,5},
Lucas Porcello Schilling^{6,7,8}, Márcio Luiz Figueiredo Balthazar⁹, Norberto Anízio Ferreira Frota^{10,11},
Leonardo Cruz de Souza¹², Paulo Caramelli¹², Paulo Henrique Ferreira Bertolucci¹³,
Márcia Lorena Fagundes Chaves^{14,15}, Sonia Maria Dozzi Brucki¹, Ricardo Nitrini¹,
Elisa de Paula França Resende¹⁶, Francisco Assis Carvalho Vale¹⁷

Estrato de escolaridade e ponto de corte

Analfabeto	1–4 anos	5–8 anos	9–11 anos	12+ anos
corte ≤ 11	corte ≤ 17	corte ≤ 19	corte ≤ 19	corte ≤ 21

3.ADIÇÃO DA ANAMNESE ALÉM DO SOCIODEMOGRÁFICO

- Necessidade de incluir **anamnese** para entender o contexto e a autopercepção e impactos na vida diária

Tabela 1. Anamnese direcionada de pacientes com queixas cognitivas e comportamentais.

Sintomas cognitivos	Atenção	Tem momentos em que fica mais confuso ou desorientado? Facilmente se distrai? Não sabe onde deixou objetos?
	Memória	Mais dificuldade em se lembrar de fatos recentes do que os mais antigos? Tem apresentado desorientação temporal? Mais repetitivo nas conversas ou pergunta várias vezes a mesma coisa? Necessita de mais anotações para se lembrar? Tem esquecido compromissos?
	Linguagem	Tem dificuldade de encontrar palavras? Não sabe nomear objetos? Está com dificuldade de articular as palavras? Tem dificuldade de compreender o que lhe é falado?
	Orientação espacial	Tem se perdido em caminhos previamente conhecidos? Tem dificuldade em aprender novos caminhos? Tem dificuldade de se localizar dentro de casa?
	Praxias	Dificuldade no uso de não saber como se usa ferramentas ou objetos conhecidos? Dificuldades em se vestir?
	Funções executivas	Está com dificuldades de planejar ou organizar o dia ou tarefas futuras? Tem dificuldade em realizar tarefas com diversas etapas? Tem dificuldade de resolver os problemas do dia a dia? Não consegue tomar decisões?
Funcionalidade	Atividades instrumentais de vida diária (AIVDs)	Tem dificuldades em manusear dinheiro, erra pagamentos? Dificuldades em fazer compras? O rendimento no trabalho diminuiu ou foi afastado? Erra na preparação de refeições?
	Atividades básicas de vida diária (ABVDs)	É capaz de realizar de forma independente e autônoma alguma das seguintes atividades: Vestir-se / Banho / Higiene / Alimentar-se / Transferência / Continência

Continua...

Sintomas comportamentais e neuropsiquiátricos	Humor	Parece triste ou desanimado? Chora facilmente? Não vê prazer na vida ou diz não ter mais futuro? Está mais irritado ou impaciente? Está se isolando, não convivendo com os outros?
	Ansiedade	Fica preocupado sobre eventos planejados? É incapaz de relaxar ou é excessivamente tenso? Preocupa-se excessivamente mesmo com coisas triviais?
	Apatia	Não tem interesse pelo mundo à (sua) volta? Está mais difícil engajar-se em conversas ou em afazeres? Está mais indiferente?
	Desinibição	Age impulsivamente, sem pensar? Tem dito coisas que não devem ser faladas em público? Tem agido de forma constrangedora? Mudou a personalidade? Está mais isolado socialmente?
	Agitação	O paciente é pouco cooperativo? Não permite ser ajudado? O paciente é agressivo verbal ou fisicamente? Fica mexendo em objetos à sua volta repetidamente? Tem tido comportamento ritualístico ou compulsivo?
	Delírios	Acredita em coisas que não são reais? Acha que alguém está tentando fazer-lhe mal ou roubá-lo? Afirma que seus parentes não são quem dizem ser? Afirma que a casa onde mora não é sua?
	Alucinações	Relata ouvir vozes ou age como se ouvisse vozes? Conversa sozinho? Vê pessoas ou animais que não são vistos pelos outros? Comporta-se como se visse algo que os outros não vêem?
	Apetite	Apresentou alguma mudança no hábito alimentar? Mudou a preferência alimentar (p.e., passou a ter preferência por doces)?
	Sono	Tem dificuldade de iniciar ou manter o sono? Fala ou se movimenta no sono como se estivesse acordado? Tem sonhos vívidos ou pesadelos frequentemente? Tem apnéia? Acorda fadado? Tem apnéia diurna?

3. ADIÇÃO DA ANAMNESE ALÉM DO SOCIODEMOGRÁFICO

- Domínios do sociodemográfico

Importante ressaltar que em todas as etapas **estamos anotando nossas obsevações e informações que vão além dos questionários, que podem ser **usados no relatório***

Seção 2 de 7

1. Abertura

Descrição (opcional)

Para começarmos: há quantos anos o(a) senhor(a) mora aqui no Cidade Madura? *

Número de anos. Se for menos de 1 ano, registre 0.

Texto de resposta curta

Seção 3 de 7

2. Estado Pré-Exame (EEG/HRV)

Descrição (opcional)

Pensando na noite passada, antes de vir hoje: o(a) senhor(a) diria que dormiu bem, mais ou menos, ou mal? *

☐ Bem

☐ Mais ou menos

☐ Mal

Seção 4 de 7

3. Trajetória e Reserva

Descrição (opcional)

Ao todo, quantos anos o(a) senhor(a) estudou? *

Anos completos de estudo formal. Nunca estudou = 0.

Texto de resposta curta

Seção 5 de 7

4. Saúde e Histórico Clínico

Descrição (opcional)

O(a) senhor(a) enxerga bem, com ou sem óculos? *

☐ Enxergo bem sem óculos

☐ Enxergo bem com óculos

☐ Enxergo com dificuldade mesmo com óculos

☐ Enxergo muito mal ou não enxergo

Seção 6 de 7

5. Vida Social

Descrição (opcional)

Considerando todo o seu círculo social (familiares, amigos e conhecidos), com quantas pessoas o(a) senhor(a) mantém contato regular e convive pelo menos uma vez ao mês? *

☐ Nenhuma (0 pessoas)

☐ De 1 a 2 pessoas

☐ De 3 a 5 pessoas

☐ 6 pessoas ou mais

Seção 7 de 7

6. Socioeconômico

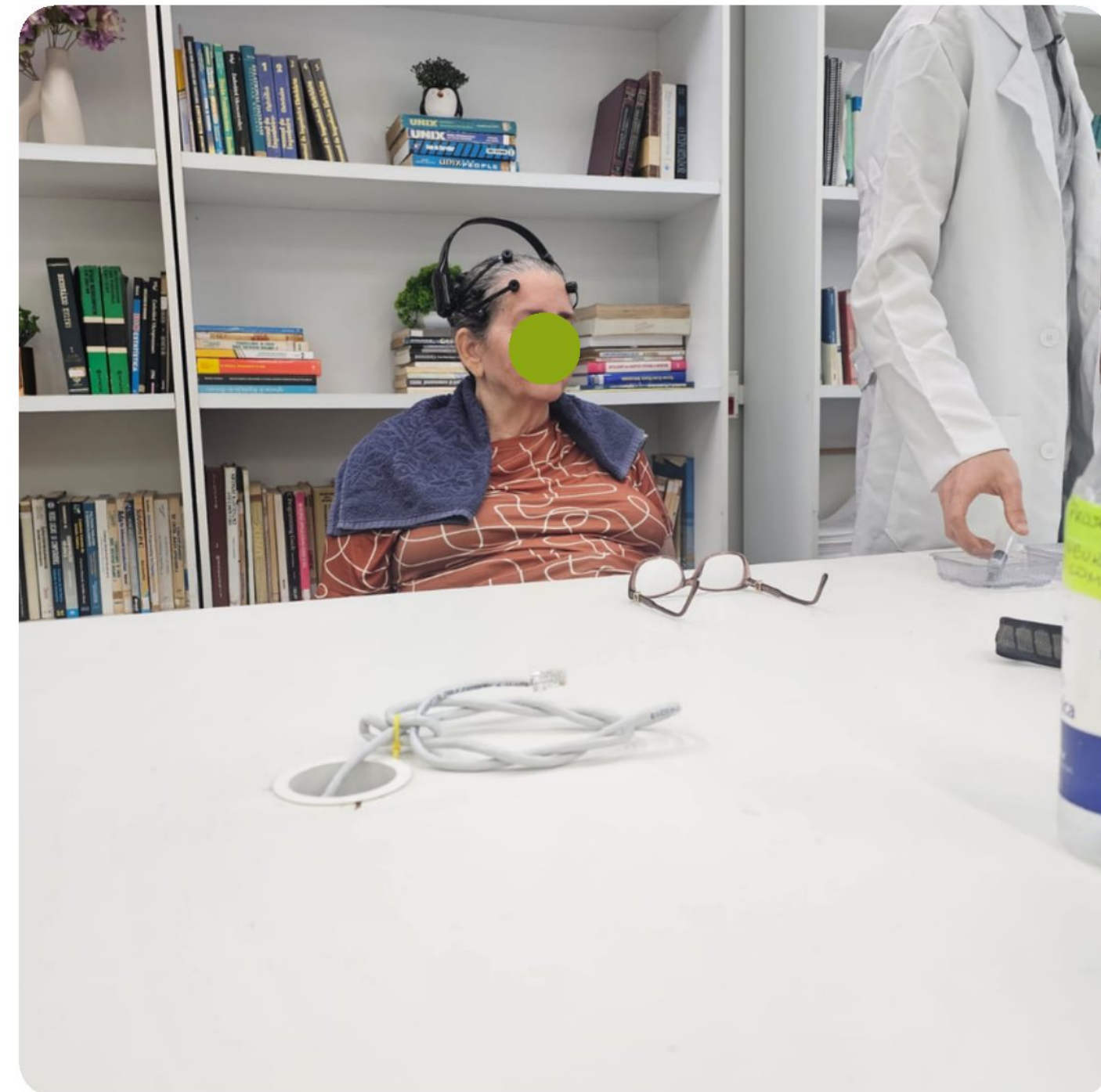
Descrição (opcional)

Para entender melhor o contexto geral: somando tudo o que entra na sua casa por mês, quanto o(a) senhor(a) ganha? (pode responder pelo cartão-resposta) *

Valor em reais, somando toda a renda domiciliar. A renda per capita será calculada na análise (renda ÷ n_moradores).

Texto de resposta curta

4.PRIMEIRA COLETA EM UMA PESSOA IDOSA



5. TEMPLATE DO RELATÓRIO E O PRIMEIRO RELATÓRIO



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
PROJETO DE EXTENSÃO: MONITORAMENTO COGNITIVO NO ENVELHECIMENTO:
AÇÕES DE CUIDADO PROMOÇÃO DE SAÚDE COM USO DE NEUROTECNOLOGIA
EM CONTEXTOS COMUNITÁRIOS

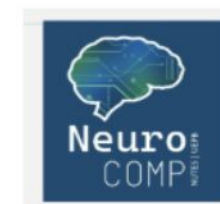
RELATÓRIO DE RASTREIO COGNITIVO

Coordenador(a) responsável:	Registro profissional: _____
Data da avaliação:	Data de emissão: ____ / ____ / ____

1. Identificação do participante

Nome completo:	Idade: Sexo:
Data de nascimento:	Escolaridade (anos completos):
Profissão:	Complexidade ocupacional:

TEMPLATE



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
PROJETO DE EXTENSÃO: MONITORAMENTO COGNITIVO NO ENVELHECIMENTO:
AÇÕES DE CUIDADO PROMOÇÃO DE SAÚDE COM USO DE NEUROTECNOLOGIA
EM CONTEXTOS COMUNITÁRIOS

RELATÓRIO DE RASTREIO COGNITIVO

Coordenador(a) responsável:	Registro profissional: _____
Data da avaliação: 20/08/2026	Data de emissão: ____ / ____ / ____

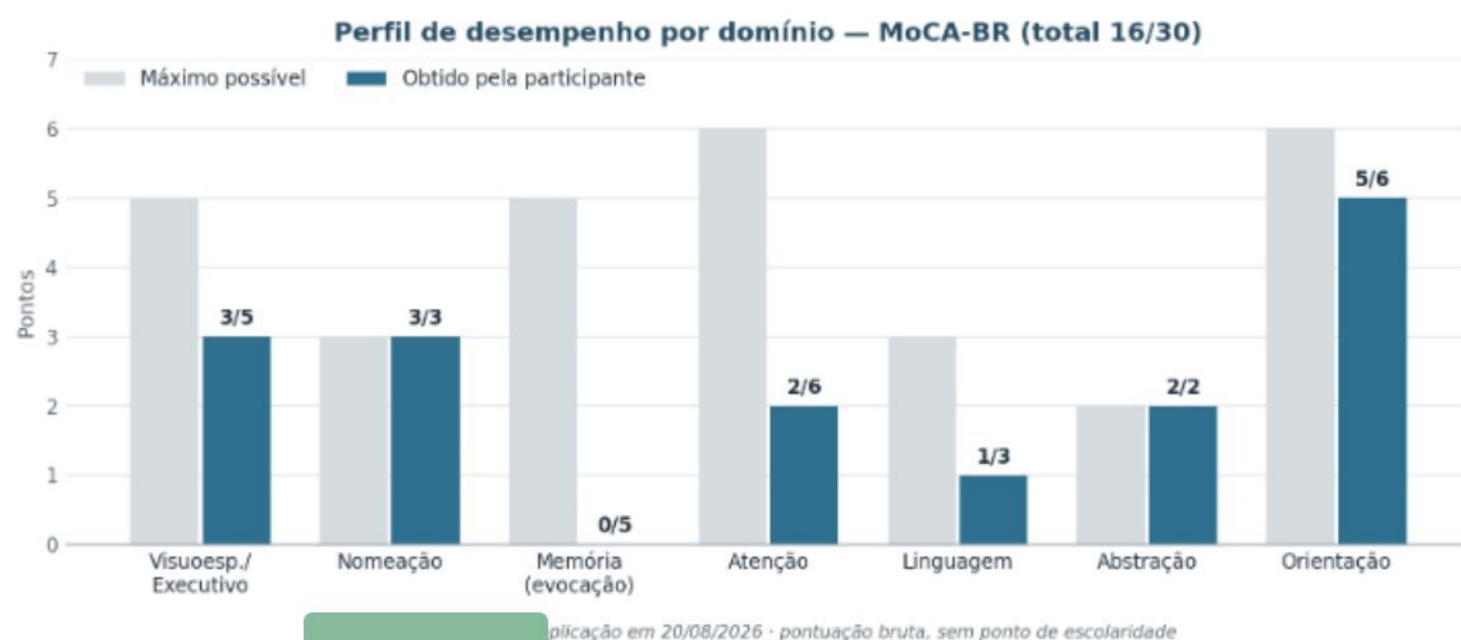
1. Identificação do participante

Nome completo	Idade: 70 anos Sexo: feminino
Data de nascimento	Escolaridade (anos completos): 19 anos (pós-graduação)
Profissão: professora (aposentada)	Complexidade ocupacional: não manual complexa (intelectual)

RELATÓRIO DA PRIMEIRA IDOSA

5. TEMPLATE DO RELATÓRIO E O PRIMEIRO RELATÓRIO

LINK DO RELATÓRIO DA PRIMEIRA IDOSA



6. DASS-21

A Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse (DASS-21) é um questionário com 21 perguntas criado para medir os níveis de depressão, ansiedade e estresse.

Subescala	Soma dos itens	Escore (soma × 2)	Faixa de severidade
Depressão	0	0	Normal
Ansiedade	0	0	Normal
Estresse	2	4	Normal

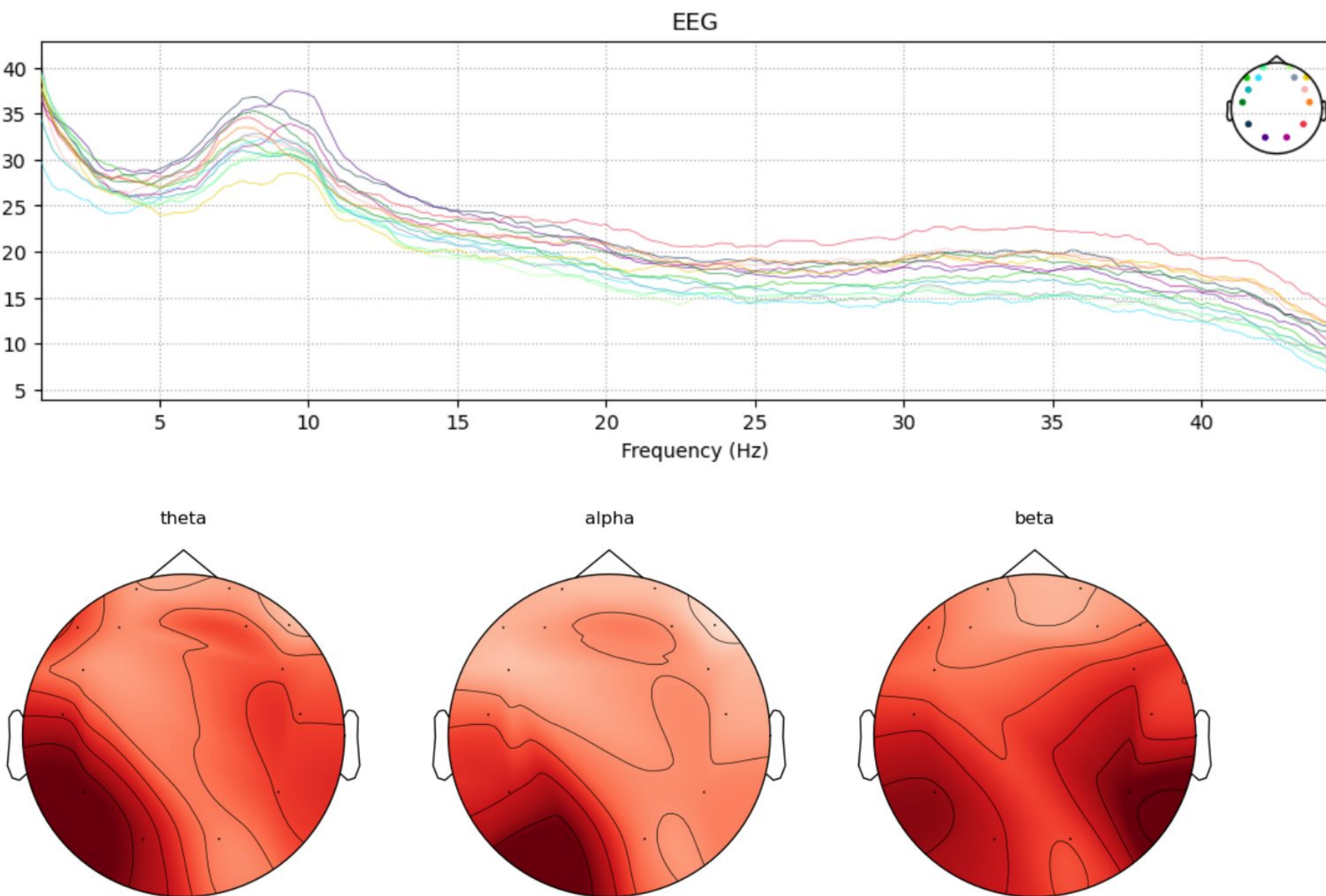
1.1 Check de sintomas por subescala

Assinalar a faixa correspondente ao escore obtido em cada subescala.

Subescala	Normal	Leve	Moderado	Grave	Extrem. grave
Depressão	☒ 0–9	☐ 10–13	☐ 14–20	☐ 21–27	☐ ≥ 28
Ansiedade	☒ 0–7	☐ 8–9	☐ 10–14	☐ 15–19	☐ ≥ 20
Estresse	☒ 0–14	☐ 15–18	☐ 19–25	☐ 26–33	☐ ≥ 34

✓	MoCA	Queixa	DASS	Classificação sugerida	Peso
☐	X	X	X	Saudável clássico	1.0
☐	X	X	✓	Saudável, com sintomas afetivos concomitantes	0.8
☐	X	✓	X	Declínio Cognitivo Subjetivo (DCS)	0.8
☐	X	✓	✓	Falso alarme emocional — queixa explicada pelos sintomas afetivos	0.9
☐	✓	X	X	Falta de insight / anosognosia leve	0.7
☐	✓	X	✓	Desatenção emocional — déficit possivelmente por ansiedade ou depressão	0.5
☒	✓	✓	X	CCL clássico — âncora forte para MCI	1.0

5.TEMPLATE DO RELATÓRIO E O PRIMEIRO RELATÓRIO



LINK DO RELATÓRIO DA PRIMEIRA IDOSA

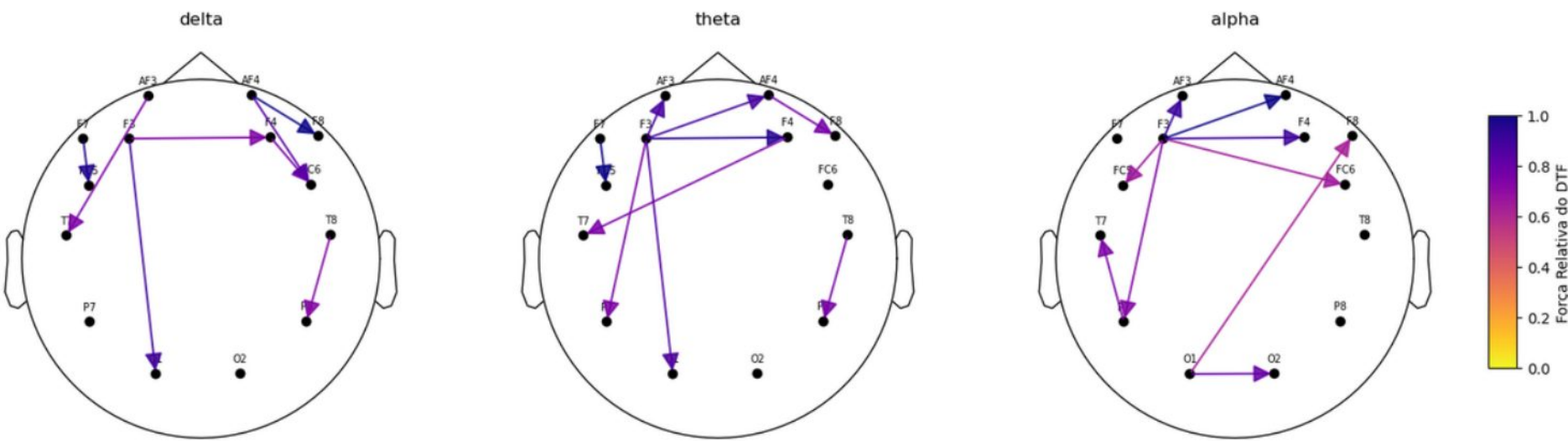
Banda	Faixa (Hz)	Padrão observado	Regiões predominantes	Leitura funcional
Delta	1-4	☒ Aumentado ☐ Reduzido ☐ Esperado	Global (Frontal, Fronto-central, Temporal, Parietal, Occipital)	Reflexo de lentificação cortical (JIANG et al., 2025; BABILONI et al., 2021; JEONG, 2004).

11

Theta	4-7	☒ Aumentado ☐ Reduzido ☐ Esperado	Fronto-central, Temporal, Parietal, Occipital	Possível impacto na codificação/recuperação de memória e atenção (HASSELMO & STERN, 2014; JIANG et al., 2025).
Alfa	8-13	☐ Aumentado ☐ Reduzido ☒ Esperado	Aumento isolado em região Temporal	Não apresentou o padrão clássico de redução occipital esperado no declínio cognitivo (KLIMESCH, 1999; BABILONI et al., 2020a).

5.TEMPLATE DO RELATÓRIO E O PRIMEIRO RELATÓRIO

LINK DO RELATÓRIO DA PRIMEIRA IDOSA

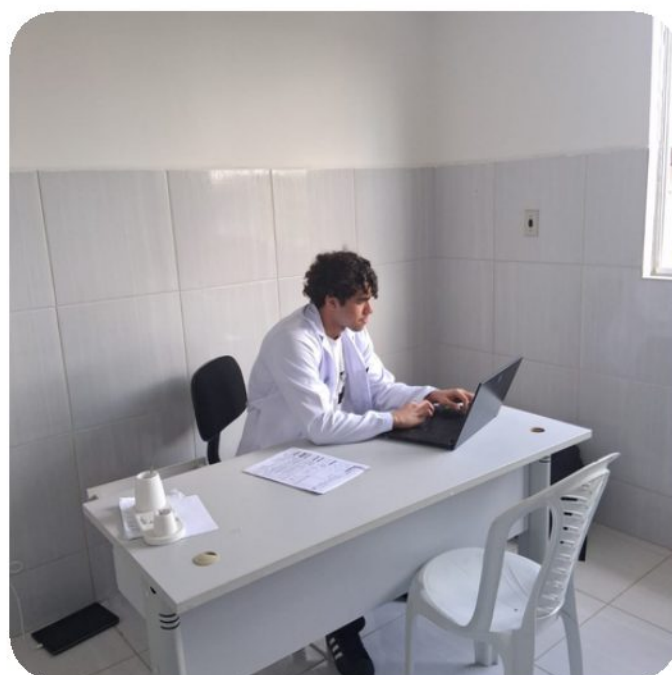
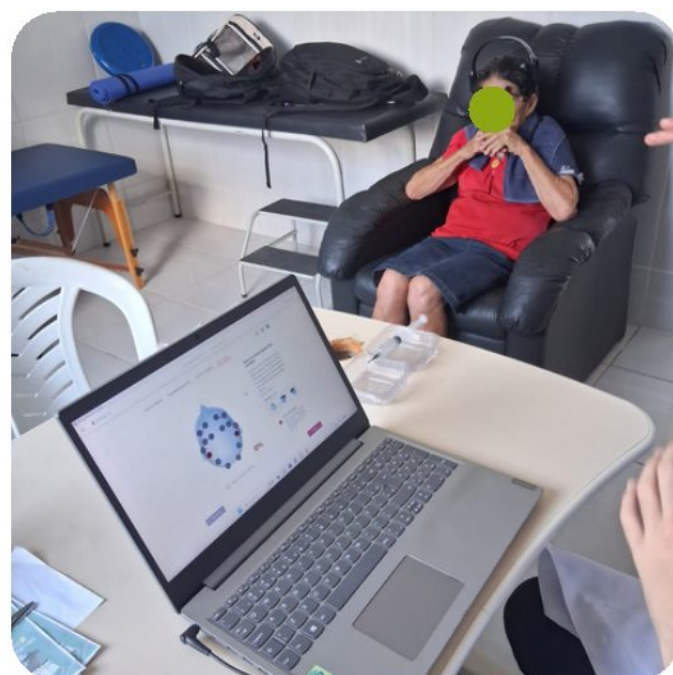
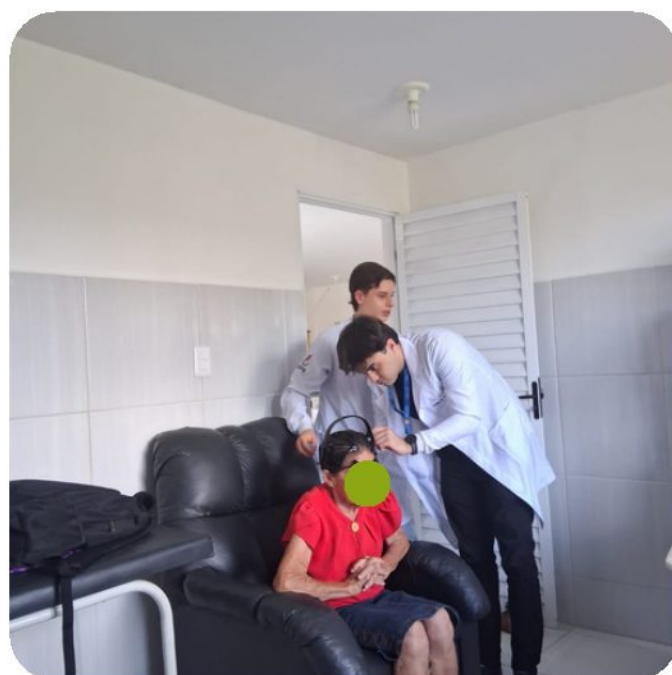


Padrão observado	Direção	Interpretação
☒ Reforço fronto-parietal	bidirecional	Pode refletir esforço compensatório de regulação atencional, sustentado por redes frontais tentando suprir déficits cognitivos (BABILONI et al., 2016; JIANG et al., 2025).
☒ Predomínio de fluxo ascendente (occipital → regiões anteriores)	bottom-up	Pode indicar maior dependência de processamento sensorial/visual primário em repouso, enviando sinais occipitais para áreas anteriores (JENSEN et al., 2014; JIANG et al., 2025).
☐ Sem alterações relevantes	—	—

5. TEMPLATE DO RELATÓRIO E O PRIMEIRO RELATÓRIO

- A ideia é que vamos ir **entregando os relatórios** na medida que vamos coletando os dados.
- Tentamos fazer o **relatório explicado** e minimamente claro para o usuário.
- Como fazer a **entrevista de devolução** do relatório?

6.PRIMEIRAS COLETAS DA CIDADE MADURA E DIVISÃO



- **Início das coletas** no dia 24 de Agosto.
- Decidimos **dividir** a coleta em 3 etapas:
 - 1) Coleta do EEG
 - 2) Sociodemográfico + MoCA
 - 3) Anamnese + Dass 21
- Dessa forma **reduz o viés** de varios aplicadores.
- Foi **adiconado a coleta** em simutâneo do EEG + **HRV** (Variância da Frequência Cardíaca).

6.PRIMEIRAS COLETAS DA CIDADE MADURA E DIVISÃO

- As coletas estão sendo feitas **quinzenalmente**
- **A cada dia de coleta** é realizada uma avaliação completa nas 3 etapas em **3 idosos**.
- O tempo gasto **em cada etapa**
 - EEG: 20 min
 - Sociodemográfico + MoCA: 40min
 - Anamnese + Dass 21: 45min
- **Acompanhamento de profissional durante as coletas** por Leornado (doutorando em fisioterapia na UFRN e Thaynara como profissional de psicologia (colação de grau em outubro)
- Possibilidade de **contar como estágio?**

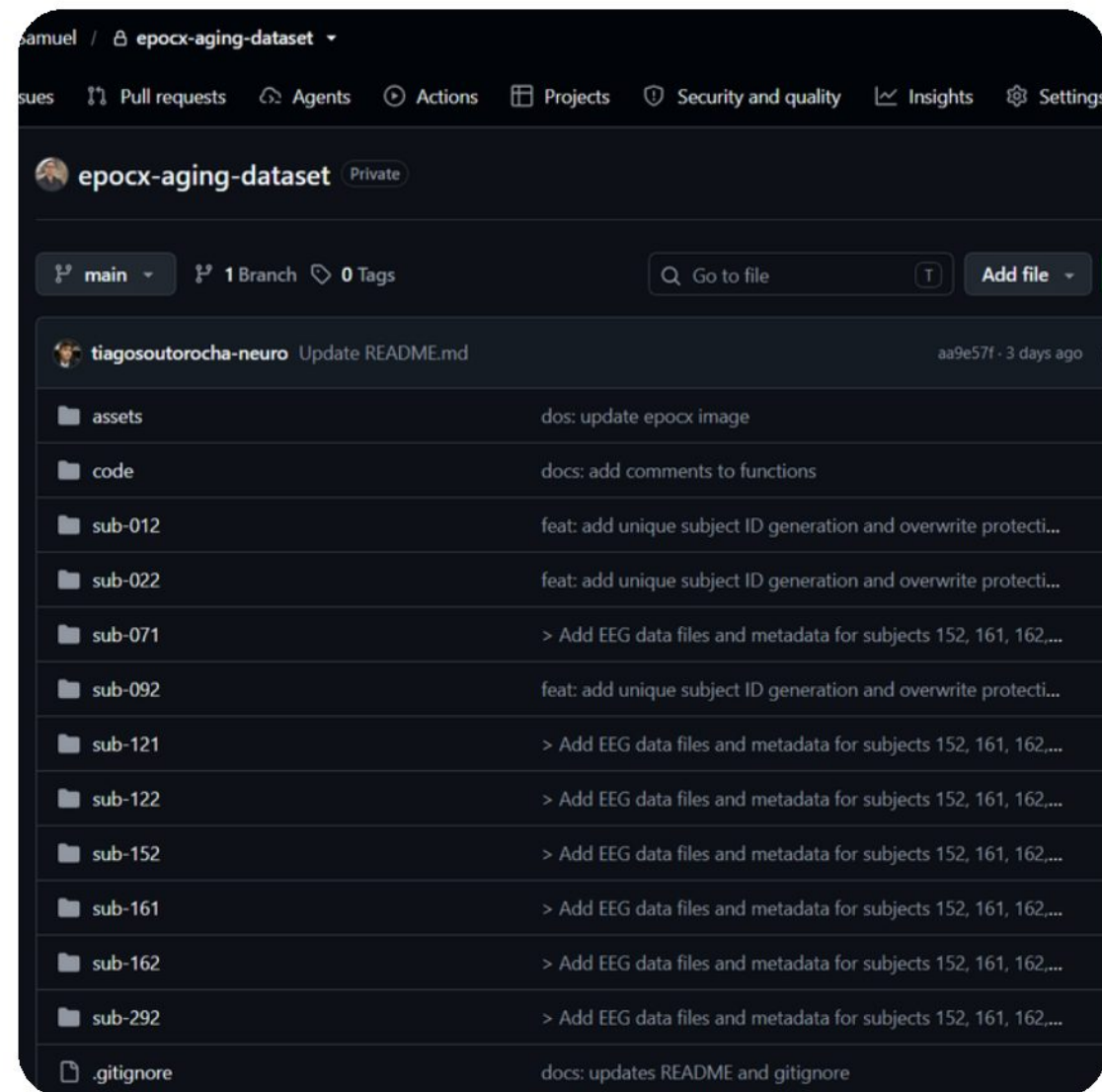


Leonardo

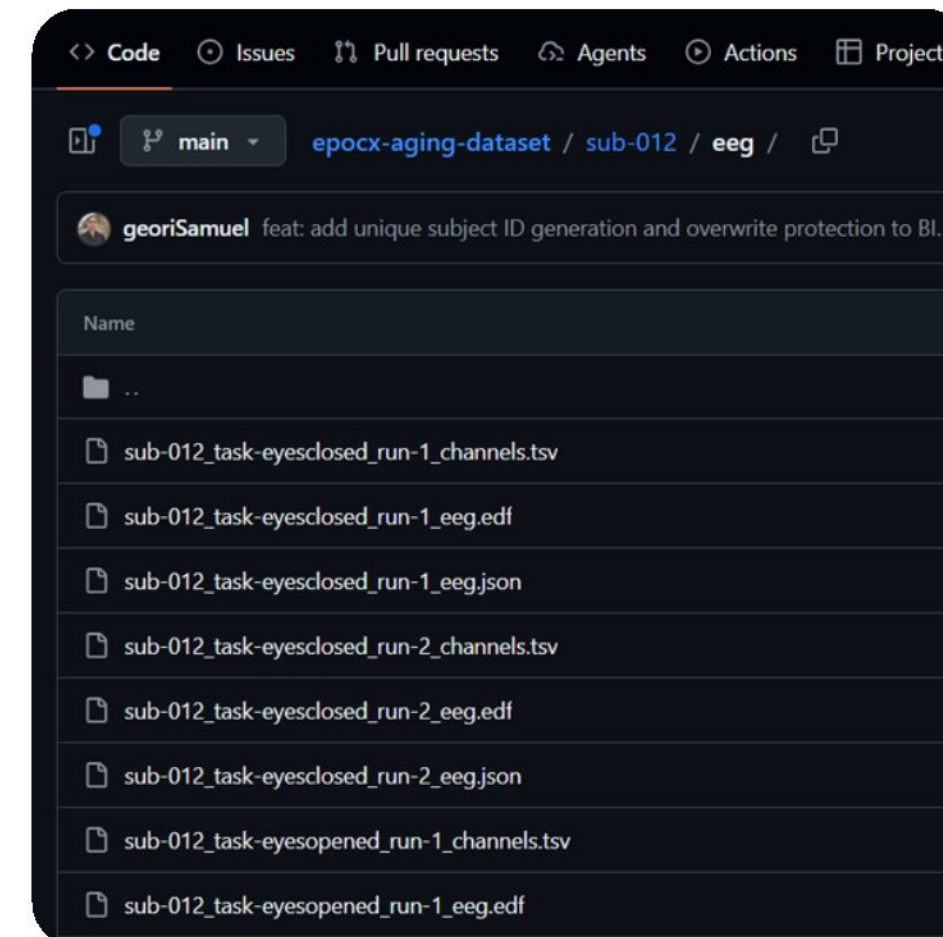
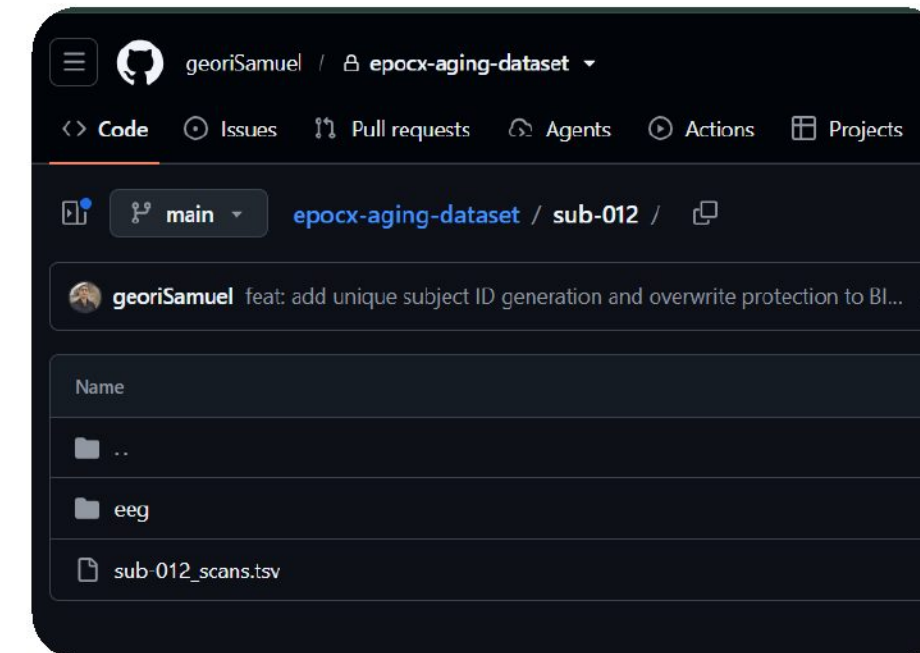
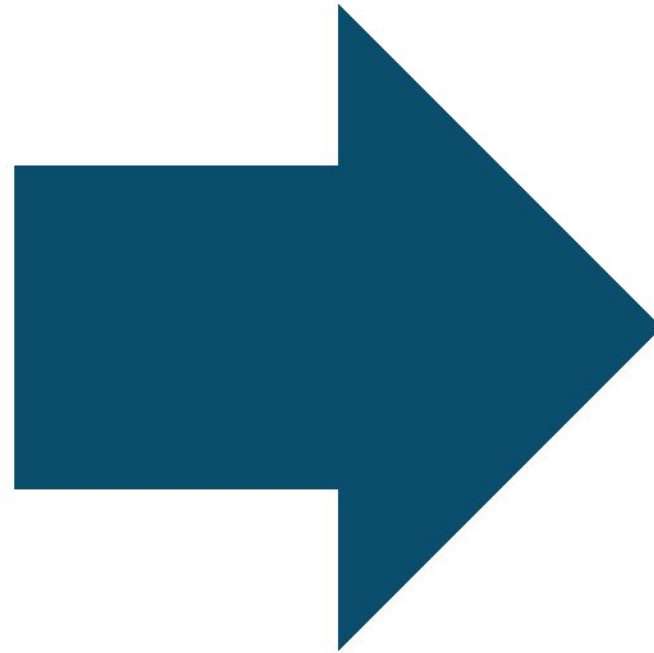


Thaynara

7.RESULTADOS PRELIMINARES

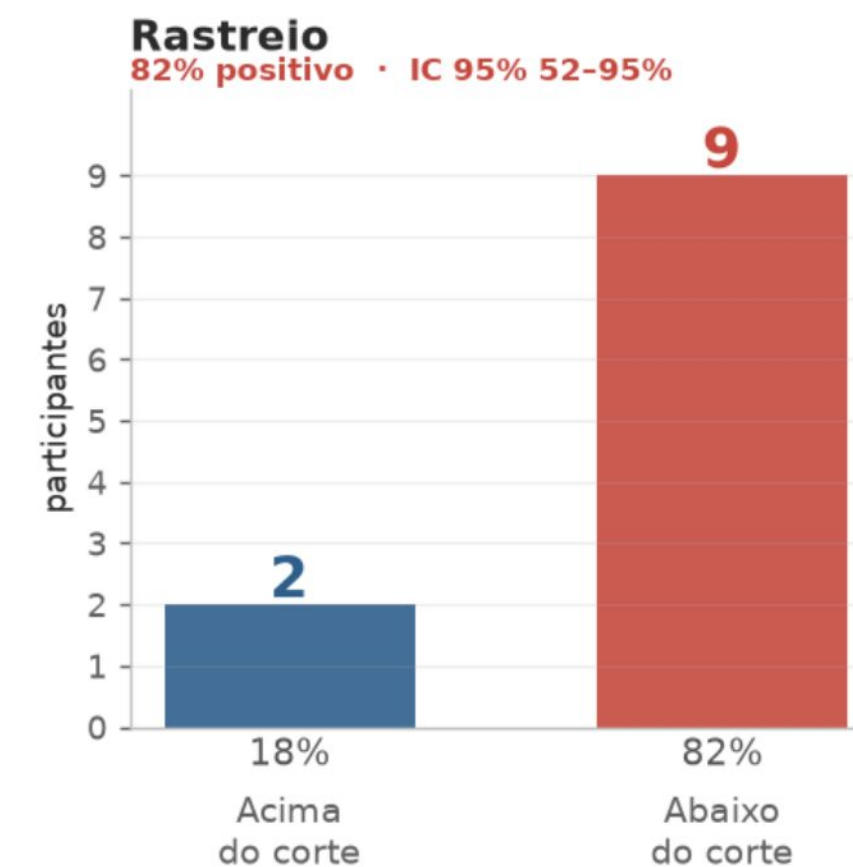
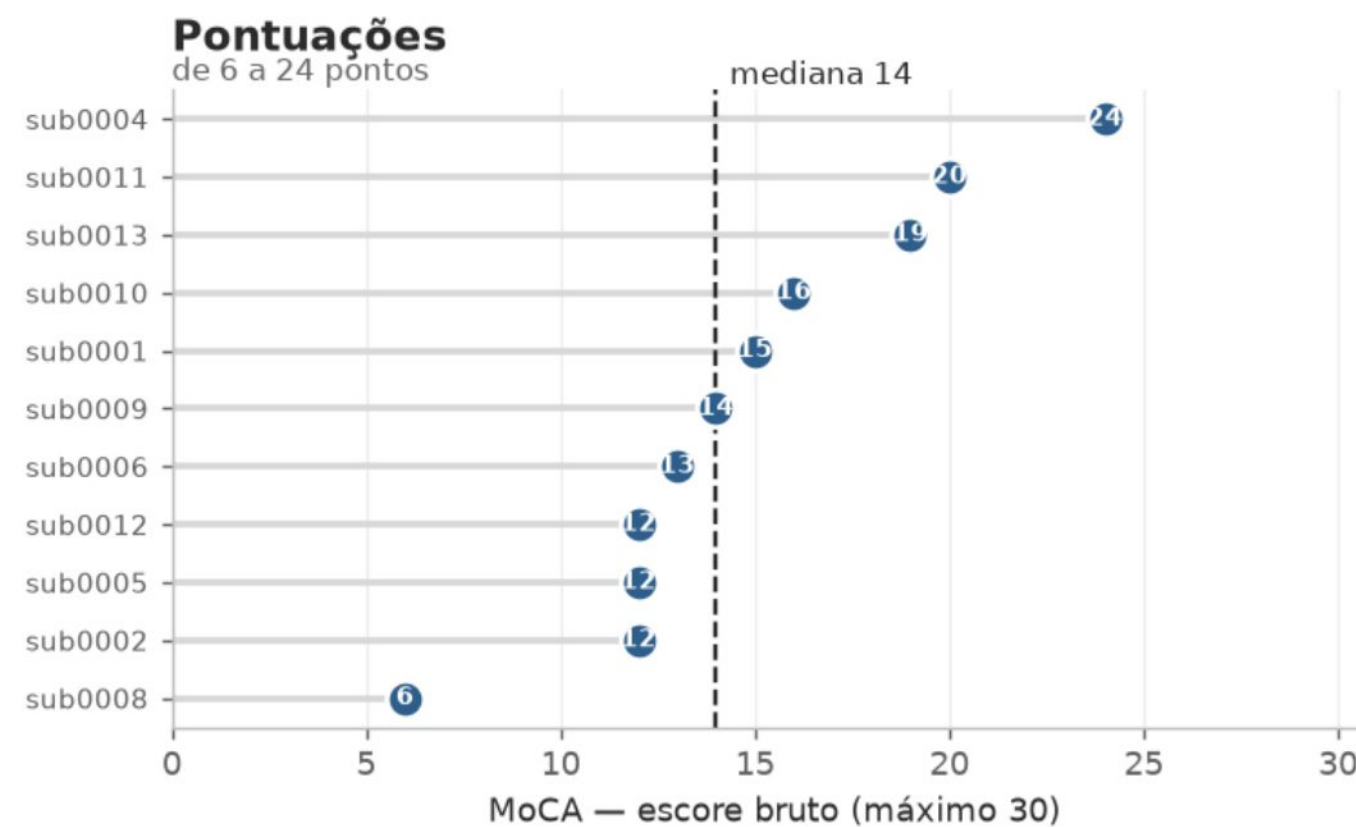
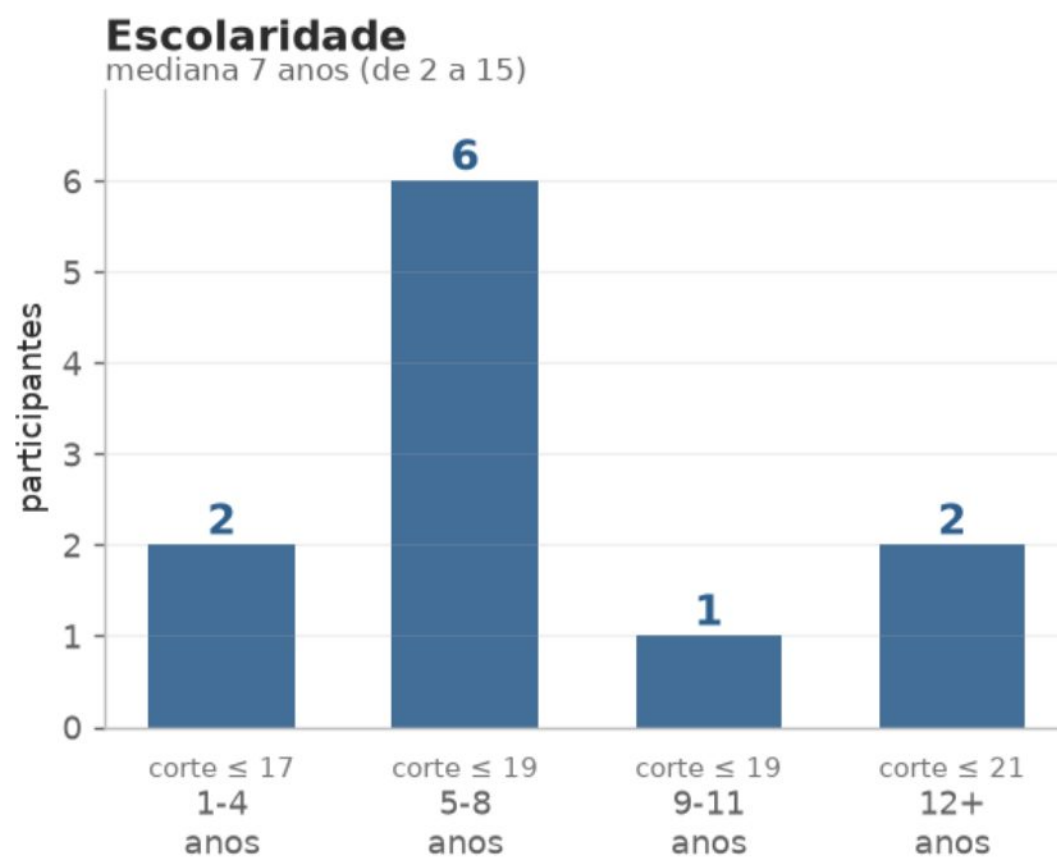


NOSSO BANCO DE
($N = 13$)

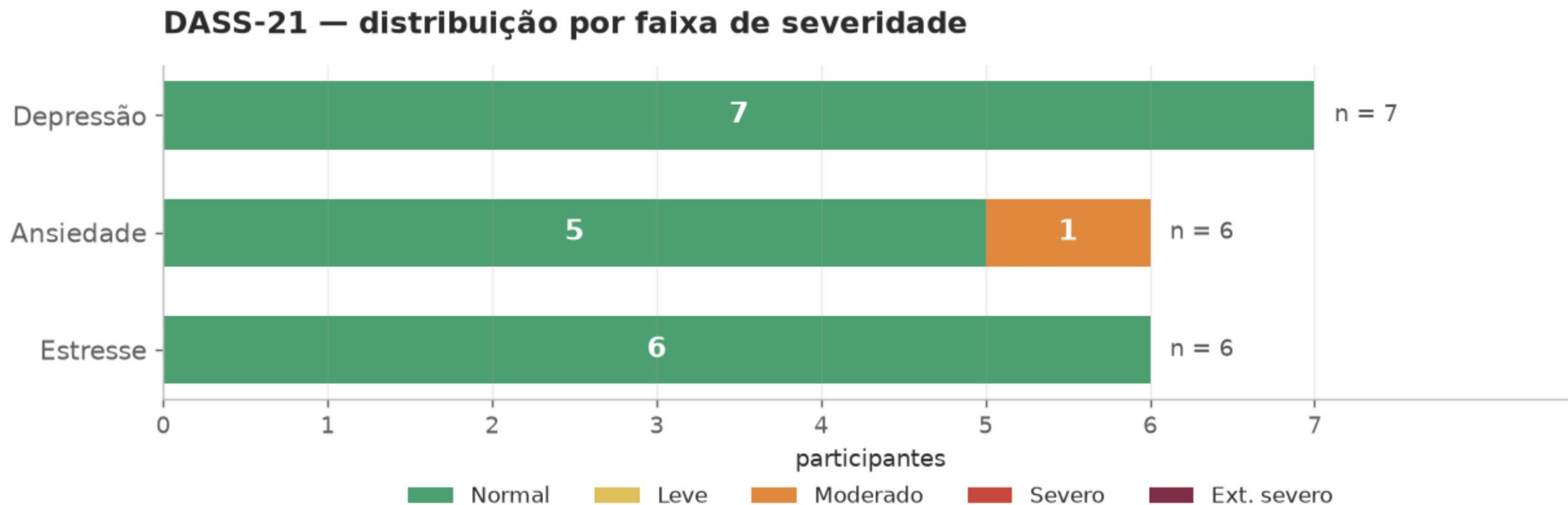


7.RESULTADOS PRELIMINARES

MoCA — escolaridade, desempenho e classificação • n = 11



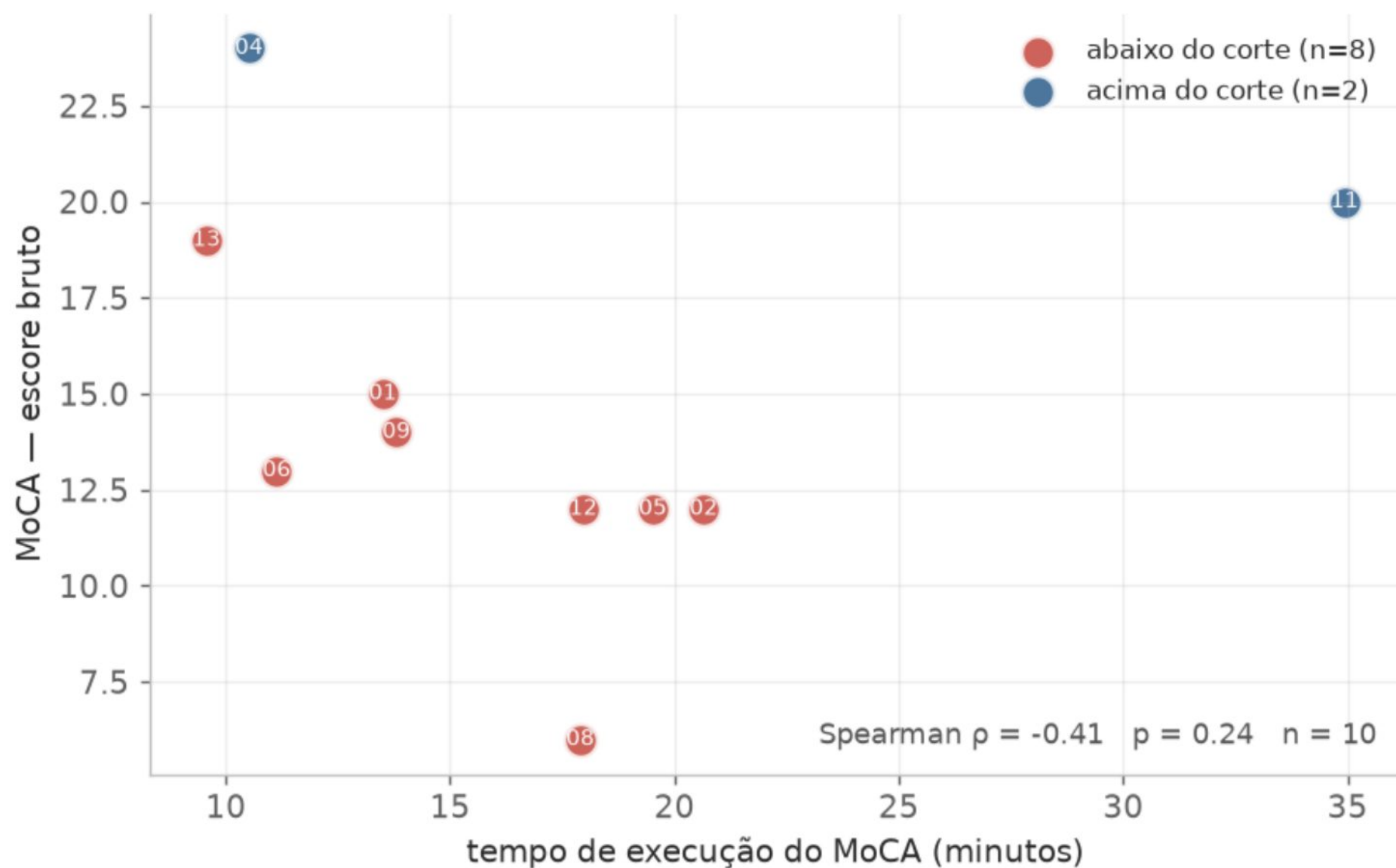
7.RESULTADOS PRELIMINARES



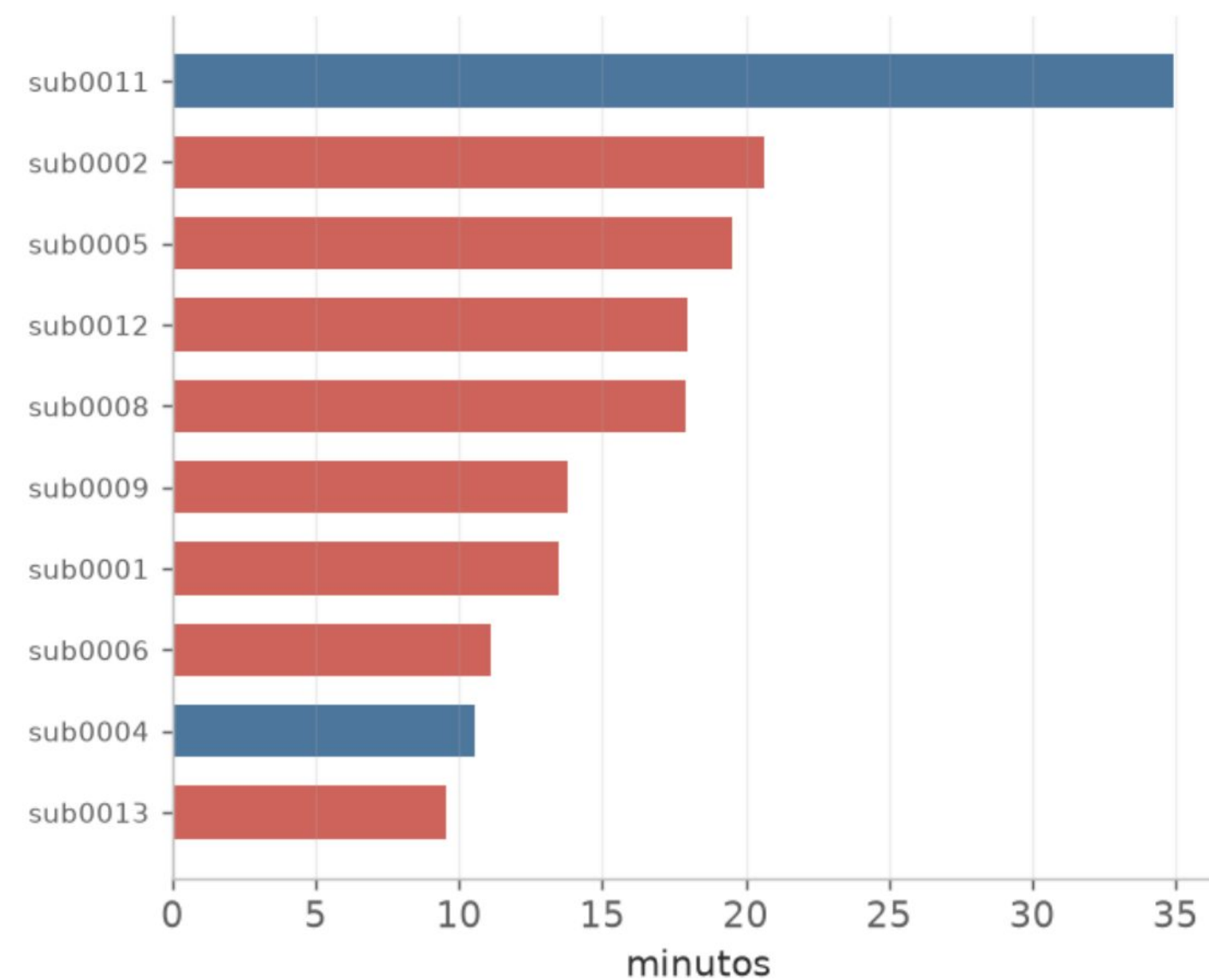
**Viés religioso e medicamentoso*

7.RESULTADOS PRELIMINARES

Tempo e pontuação são eixos independentes



De 10 a 35 minutos (3.7× de variação)

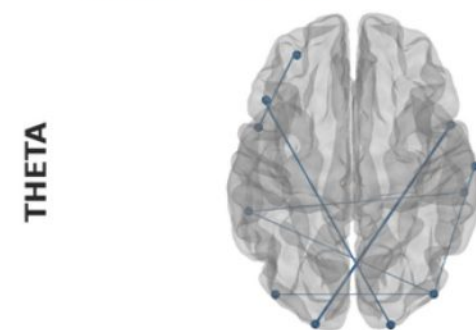


7.RESULTADOS PRELIMINARES

Conectividade funcional individual — extremos do MoCA

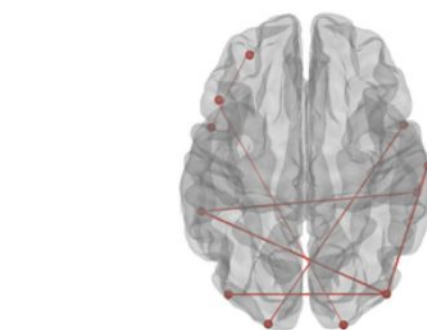
EEG em repouso, olhos fechados · wPLI · sub0004 (MoCA 24) vs sub0008 (MoCA 6) · dois indivíduos, não uma amostra

sub0004 · MoCA 24



wPLI médio da banda: 0.271

sub0008 · MoCA 6

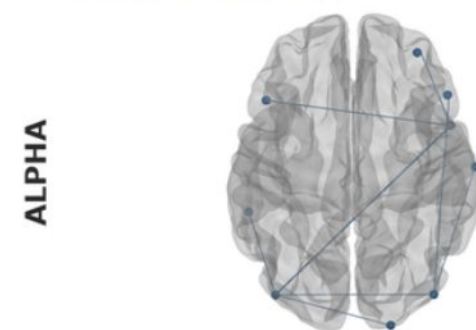


wPLI médio da banda: 0.290

ARESTA	REGIÕES	MoCA 24	MoCA 6	Δ
T7 ↔ P8	Temporal ↔ Parietal	0.19	0.59	+0.41
O1 ↔ F8	Frontal ↔ Occipital	0.78	0.39	-0.39
P7 ↔ P8	Parietal ↔ Parietal	0.19	0.56	+0.37
P8 ↔ FC6	Frontal ↔ Parietal	0.22	0.58	+0.36
T8 ↔ FC6	Frontal ↔ Temporal	0.21	0.49	+0.28
T7 ↔ T8	Temporal ↔ Temporal	0.19	0.46	+0.27
F3 ↔ O2	Frontal ↔ Occipital	0.43	0.18	-0.25
AF3 ↔ F7	Frontal ↔ Frontal	0.40	0.16	-0.25

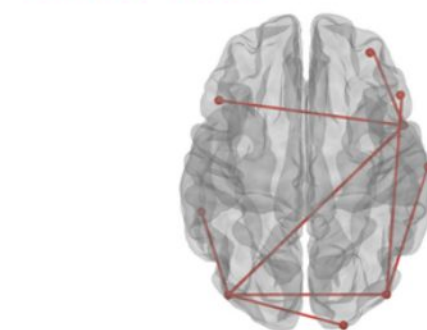
wPLI médio da banda inteira: 0.271 vs 0.290 (Δ +0.019)

sub0004 · MoCA 24



wPLI médio da banda: 0.313

sub0008 · MoCA 6

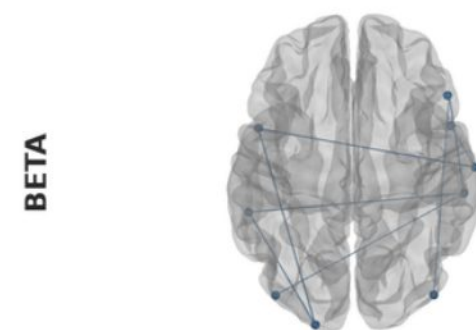


wPLI médio da banda: 0.545

ARESTA	REGIÕES	MoCA 24	MoCA 6	Δ
T7 ↔ P7	Temporal ↔ Parietal	0.24	0.87	+0.63
P8 ↔ FC6	Frontal ↔ Parietal	0.18	0.79	+0.61
P8 ↔ F4	Frontal ↔ Parietal	0.23	0.79	+0.56
F8 ↔ AF4	Frontal ↔ Frontal	0.26	0.81	+0.55
P7 ↔ P8	Parietal ↔ Parietal	0.21	0.76	+0.55
F3 ↔ F8	Frontal ↔ Frontal	0.23	0.76	+0.53
P7 ↔ F8	Frontal ↔ Parietal	0.39	0.91	+0.52
P7 ↔ O2	Parietal ↔ Occipital	0.20	0.71	+0.51

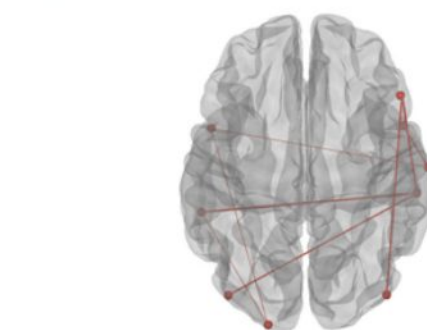
wPLI médio da banda inteira: 0.313 vs 0.545 (Δ +0.232)

sub0004 · MoCA 24



wPLI médio da banda: 0.257

sub0008 · MoCA 6



wPLI médio da banda: 0.239

ARESTA	REGIÕES	MoCA 24	MoCA 6	Δ
T7 ↔ T8	Temporal ↔ Temporal	0.26	0.59	+0.33
T8 ↔ F4	Frontal ↔ Temporal	0.26	0.60	+0.33
P8 ↔ F4	Frontal ↔ Parietal	0.19	0.51	+0.32
P7 ↔ T8	Temporal ↔ Parietal	0.19	0.44	+0.25
FC6 ↔ F8	Frontal ↔ Frontal	0.20	0.43	+0.23
F7 ↔ O1	Frontal ↔ Occipital	0.33	0.15	-0.19
F7 ↔ FC6	Frontal ↔ Frontal	0.30	0.11	-0.19
T7 ↔ O1	Temporal ↔ Occipital	0.31	0.14	-0.17

wPLI médio da banda inteira: 0.257 vs 0.239 (Δ -0.018)

O baixo desempenho cognitivo foi acompanhado por uma reorganização da conectividade, com marcada alteração da sincronização em alpha.

7.RESULTADOS PRELIMINARES

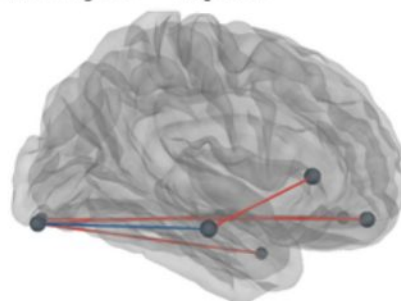
Arestas de conectividade associadas ao desempenho cognitivo

EEG em repouso · wPLI · correlação de Spearman · $|\rho| \geq 0.75$ · análise exploratória

● ρ positivo

● ρ negativo

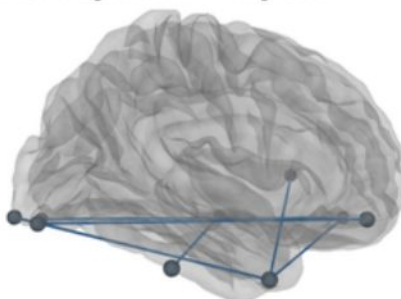
Nomeação · alpha



ARESTA	REGIÕES	ρ
F7 ↔ P8	Frontal ↔ Parietal	+0.93
P8 ↔ FC6	Frontal ↔ Parietal	-0.93
FC5 ↔ P8	Frontal ↔ Parietal	+0.85
FC6 ↔ F4	Frontal ↔ Frontal	+0.77
O1 ↔ AF4	Frontal ↔ Occipital	+0.77
AF3 ↔ FC5	Frontal ↔ Frontal	+0.77

6 arestas $\geq |\rho| 0.75$ · 5 positivas · 1 negativas

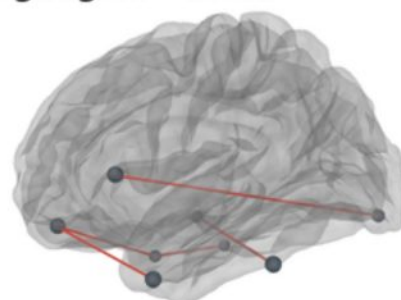
Visuoespacial · alpha



ARESTA	REGIÕES	ρ
FC5 ↔ T8	Frontal ↔ Temporal	-0.91
O2 ↔ F8	Frontal ↔ Occipital	-0.87
F3 ↔ F8	Frontal ↔ Frontal	-0.81
P8 ↔ AF4	Frontal ↔ Parietal	-0.79
AF3 ↔ O1	Frontal ↔ Occipital	-0.79
AF3 ↔ F8	Frontal ↔ Frontal	-0.79

6 arestas $\geq |\rho| 0.75$ · 0 positivas · 6 negativas

Linguagem · theta



ARESTA	REGIÕES	ρ
T8 ↔ F8	Frontal ↔ Temporal	+0.91
F3 ↔ O2	Frontal ↔ Occipital	+0.87
T7 ↔ FC6	Frontal ↔ Temporal	+0.81
AF3 ↔ F8	Frontal ↔ Frontal	+0.77
AF3 ↔ F7	Frontal ↔ Frontal	+0.77

5 arestas $\geq |\rho| 0.75$ · 5 positivas · 0 negativas

7.RESULTADOS PRELIMINARES

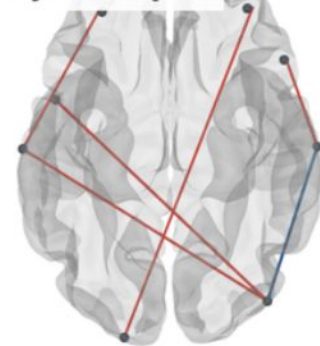
Arestas de conectividade associadas ao desempenho cognitivo

EEG em repouso · wPLI · correlação de Spearman · $|\rho| \geq 0.75$ · análise exploratória

● ρ positivo

● ρ negativo

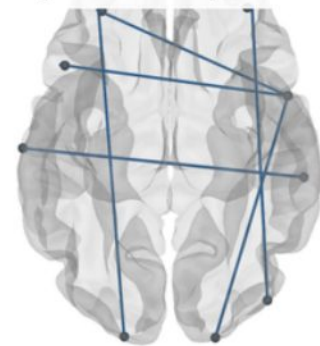
Nomeação · alpha



ARESTA	REGIÕES	ρ
F7 ↔ P8	Frontal ↔ Parietal	+0.93
P8 ↔ FC6	Frontal ↔ Parietal	-0.93
FC5 ↔ P8	Frontal ↔ Parietal	+0.85
FC6 ↔ F4	Frontal ↔ Frontal	+0.77
O1 ↔ AF4	Frontal ↔ Occipital	+0.77
AF3 ↔ FC5	Frontal ↔ Frontal	+0.77

6 arestas $\geq |\rho| 0.75$ · 5 positivas · 1 negativas

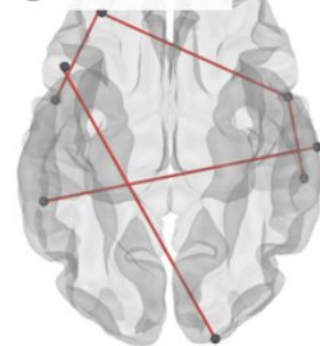
Visuoespacial · alpha



ARESTA	REGIÕES	ρ
FC5 ↔ T8	Frontal ↔ Temporal	-0.91
O2 ↔ F8	Frontal ↔ Occipital	-0.87
F3 ↔ F8	Frontal ↔ Frontal	-0.81
P8 ↔ AF4	Frontal ↔ Parietal	-0.79
AF3 ↔ O1	Frontal ↔ Occipital	-0.79
AF3 ↔ F8	Frontal ↔ Frontal	-0.79

6 arestas $\geq |\rho| 0.75$ · 0 positivas · 6 negativas

Linguagem · theta



ARESTA	REGIÕES	ρ
T8 ↔ F8	Frontal ↔ Temporal	+0.91
F3 ↔ O2	Frontal ↔ Occipital	+0.87
T7 ↔ FC6	Frontal ↔ Temporal	+0.81
AF3 ↔ F8	Frontal ↔ Frontal	+0.77
AF3 ↔ F7	Frontal ↔ Frontal	+0.77

5 arestas $\geq |\rho| 0.75$ · 5 positivas · 0 negativas

7.RESULTADOS PRELIMINARES

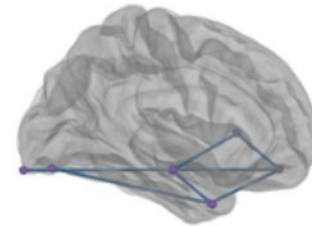
Conectividade funcional e sintomas psicológicos — DASS-21

EEG em repouso · wPLI · Spearman · vista sagital lateral · n = 4 · análise exploratória

● p positivo

● p negativo

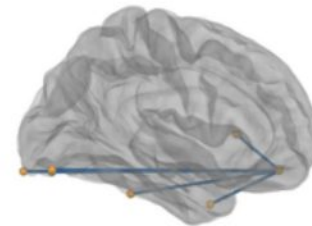
Ansiedade · beta



ARESTA	REGIÕES	p
AF3 ↔ F7	Frontal ↔ Frontal	-1.00
AF3 ↔ F3	Frontal ↔ Frontal	-1.00
AF3 ↔ O1	Frontal ↔ Occipital	-1.00
F7 ↔ P8	Frontal ↔ Parietal	-1.00
FC5 ↔ F8	Frontal ↔ Frontal	-1.00
F3 ↔ FC6	Frontal ↔ Frontal	-1.00

n = 4 · 6 associações selecionadas · 0 positivas · 6 negativas

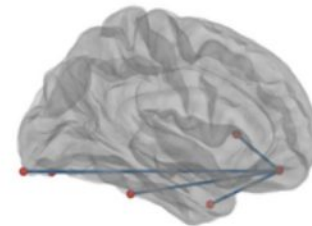
Estresse · beta



ARESTA	REGIÕES	p
AF3 ↔ F7	Frontal ↔ Frontal	-1.00
AF3 ↔ F3	Frontal ↔ Frontal	-1.00
AF3 ↔ T7	Frontal ↔ Temporal	-1.00
AF3 ↔ P8	Frontal ↔ Parietal	-1.00
AF3 ↔ P7	Frontal ↔ Parietal	-1.00
AF3 ↔ O1	Frontal ↔ Occipital	-1.00

n = 3 · 6 associações selecionadas · 0 positivas · 6 negativas

Depressão · beta



ARESTA	REGIÕES	p
AF3 ↔ F7	Frontal ↔ Frontal	-0.77
AF3 ↔ F3	Frontal ↔ Frontal	-0.77
AF3 ↔ FC5	Frontal ↔ Frontal	-0.77
AF3 ↔ T7	Frontal ↔ Temporal	-0.77
AF3 ↔ P7	Frontal ↔ Parietal	-0.77
AF3 ↔ O1	Frontal ↔ Occipital	-0.77

n = 4 · 6 associações selecionadas · 0 positivas · 6 negativas

7.RESULTADOS PRELIMINARES

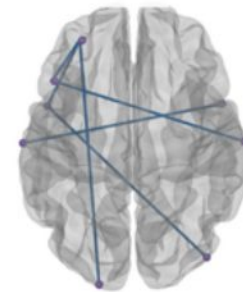
Conectividade funcional e sintomas psicológicos — DASS-21

EEG em repouso · wPLI · Spearman · n = 4 · análise exploratória

● rho positivo

● rho negativo

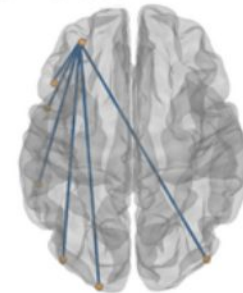
Ansiedade · beta



ARESTA	REGIÕES	p
AF3 ↔ F7	Frontal ↔ Frontal	-1.00
AF3 ↔ F3	Frontal ↔ Frontal	-1.00
AF3 ↔ O1	Frontal ↔ Occipital	-1.00
F7 ↔ P8	Frontal ↔ Parietal	-1.00
FC5 ↔ F8	Frontal ↔ Frontal	-1.00
F3 ↔ FC6	Frontal ↔ Frontal	-1.00

n = 4 · 6 associações acima/selecionadas · 0 positivas · 6 negativas

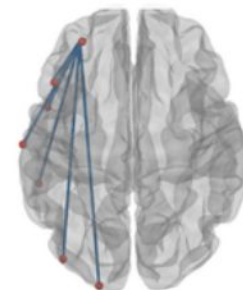
Estresse · beta



ARESTA	REGIÕES	p
AF3 ↔ F7	Frontal ↔ Frontal	-1.00
AF3 ↔ F3	Frontal ↔ Frontal	-1.00
AF3 ↔ T7	Frontal ↔ Temporal	-1.00
AF3 ↔ P8	Frontal ↔ Parietal	-1.00
AF3 ↔ P7	Frontal ↔ Parietal	-1.00
AF3 ↔ O1	Frontal ↔ Occipital	-1.00

n = 3 · 6 associações acima/selecionadas · 0 positivas · 6 negativas

Depressão · beta



ARESTA	REGIÕES	p
AF3 ↔ F7	Frontal ↔ Frontal	-0.77
AF3 ↔ F3	Frontal ↔ Frontal	-0.77
AF3 ↔ FC5	Frontal ↔ Frontal	-0.77
AF3 ↔ T7	Frontal ↔ Temporal	-0.77
AF3 ↔ P7	Frontal ↔ Parietal	-0.77
AF3 ↔ O1	Frontal ↔ Occipital	-0.77

n = 4 · 6 associações acima/selecionadas · 0 positivas · 6 negativas

p positivo: maior wPLI associado a maior escore DASS (mais sintomas); p negativo: maior wPLI associado a menor escore. wPLI é não direcionado. A análise é exploratória e não demonstra causalidade.



Neuro
Comp



Contact



Tiago Souto Rocha



NeuroComp • NUTES



State University of Paraíba



tiago.r@aluno.uepb.edu.br



Code and protocol



github.com/tiagosoutorocha-neuro